

FORMATO PROPUESTA CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

ANTECEDENTES SOCIALES RELEVANTE

Formato base (copiar y pegar en cerofilas títulos y punteos en negrita)	Ejemplos
• Nivel educativo: • Trabajo / Ocupación: • Situación familiar: *Tipología familiar Considerar cuidador • Grado de Limitación: * Descripción o comentario que esta al final del ISRA. Situación especial (considerar sólo en caso de corresponder). *Ejemplo: familia vulnerable, migrante, situación calle, escasos recursos, antecedentes de VIF, malas condiciones de habitabilidad, etc.	• Nivel educativo: Cursa Ed. Especial. PIE. Estudiante Universitario de Ingeniería. Ed. Media completa o incompleta. • Trabajo / Ocupación: Electricista, Pensionado, Cesante, etc. • Situación familiar: Vive Solo. Vive con padre. Es parte de familia extensa. • Grado de Limitación: ISRA informa requiere ayuda para realizar algunas actividades básicas como cocinar, afeitarse (Corea de Huntington). ISRA Informa: No logra comunicarse con terceros (Ca de Laringe operado). • Situación especial: habita en mediagua sin alcantarillado, solo cuenta con luz y agua por camión aljibe.

OBSERVACIONES DATOS RELEVANTES DE CALIFICACIÓN

Formato base (copiar y pegar en cerofilas títulos y punteos en negrita)	Ejemplos
INFORME BIOMÉDICO FUNCIONAL COMPLETADO POR: (Especialidad, Institución ya sea pública o privada). • Diagnósticos: *Enlistar todos y sólo los referidos en IBF. • Resumen información relevante del IBF: *Describir brevemente historia de la condición de salud. • Descripción del estado funcional: *Textual del ítem. • Medicamentos: • Ayudas Técnicas:	• INFORME BIOMÉDICO FUNCIONAL COMPLETADO POR: Neurólogo de Hospital Barros Luco. • Diagnósticos: - Amputación infracondílea derecha. - DM • Información relevante: Operado el 04-06-2026. Amputación 2º a pie diabético complicado. Antecedente DM con mal control metabólico. Otros ejemplos: Requiere uso de oxígeno, uso de SNG , Índice de Bartel, GAF, Psicometría con CIT, etc. • Descripción del estado funcional: Independiente en AVD básicas, requiere asistencia para uso de transporte público. • Medicamentos: Metformina, pregabalina. O “No” en caso de no considerar. • Ayudas Técnicas: Bastón, Silla de ruedas, OTP, Prótesis Ocular, Audífonos, etc. O “No” en caso de no considerar.
INFORMES O EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: *Consideraciones: - Se reportarán solo si son relevantes y configuran la consideración de un diagnóstico no informado en IBF. En caso de que complementen el diagnostico	INFORMES O EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: • Epicrisis: fecha 10-06-2026, diagnóstico de Egreso amputación SC. • Audiometría (07/23): compatible con una HNS bilateral moderada.

informado, solo indicar que “los informes son concordantes con diagnóstico de IBF”. - No repetir información que se reporte en IBF u otros exámenes. - Epicrisis: indicar fecha de hospitalización y diagnósticos de egreso. - Cuando se presenta el mismo examen aplicado en distintas fechas, sólo considerar el último. - Si no se adjuntan complementarios agregar: NO.	• Psicometría (03/22): WISC-V, CI Total de 41, DI moderada. • RX cadera izq (05-05-2020): compatible con artrosis de cadera. • No (en caso de no adjuntar complementarios).
IVADEC: • Aplicado a: (Si se aplica a acompañante: indicar vínculo). • Porcentaje obtenido: • Origen/es considerados:	IVADEC: • Aplicado a USUARIO. • 28,6% • ORIGEN ÚNICO FÍSICO.
	IVADEC: • Aplicado a ACOMPAÑANTE (MADRE). • 70% • ORIGEN PRINCIPAL FÍSICO Y 2º MENTAL PSÍQUICO.
OBSERVACIONES DEL IVADEC: *Describir brevemente lo evidenciado del análisis de IVADEC (orígenes corresponden, coherencia del Instrumento).	IVADEC presenta incoherencias horizontales, es decir, no se contempló el uso de AATT (bastón) en códigos de desplazamientos.
	IVADEC presenta códigos alterados no relacionados a diagnósticos de solicitud.
	IVADEC considera origen secundario sensorial visual que no cuenta con sustento clínico.
PROPUESTA: • SE SUGIERE • MR: • REEV: *Calificador de discapacidad debe proponer a la comisión médica:	PROPUESTA: • SE SUGIERE MANTENER PROPUESTA PORCENTUAL Y ORIGENES DE DISCAPACIDAD, LOS CUALES SON COHERENTES CON LOS DIAGNÓSTICOS REPORTADOS Y LA FUNCIONALIDAD EL USUARIO.

1. Mantener o modificar <u>orígenes de discapacidad</u> considerados en IVADEC, según sustento clínico e impacto de la funcionalidad (puede eliminar, agregar orígenes de discapacidad o modificar su orden). 2. Mantener o modificar (aumentar o reducir) <u>% de discapacidad</u> obtenido en IVADEC, requiere la justificación de la modificación (ej: % obtenido IVADEC no es coherente con la funcionalidad del usuario, instrumento evidencia incoherencias en su aplicación, se elimina origen de discapacidad quedando sólo con 1 origen). 3. Existencia de <u>Movilidad Reducida (MR)</u> según algoritmo: SI O NO. *Es posible proponer eliminar la MR o agregarla en caso de corresponder. 4. <u>Reevaluación</u>: NO / Periodo de años en el que se reevaluará.	MR: SÍ. REEV: EN 6 AÑOS. • SE SUGIERE ELIMINAR ORIGEN SECUNDARIO SENSORIAL AUDITIVO, DADO QUE NO CUENTA CON SUSTENTO CLÍNICO. JUNTO CON ELLO REDUCIR EL % DE DISCAPACIDAD A XX%, DADO QUE RESULTADO DE IVADEC NO ES COHERENTE CON LA FUNCIONALIDAD DEL USUARIOS. MR: NO. SE SUGIERE AGREGAR. REEV: NO. • SE SUGIERE INVERTIR ORIGENES DE DISCAPACIDAD, DADO QUE ORIGEN FÍSICO GENERA MAYOR REPERCUSIÓN FUNCIONAL QUE ORIGEN SENSORIAL AUDITIVO. Y MANTENER % OBTENIDO EN IVADEC, EL CUAL ES COHERENTE CON LA FUNCIONALIDAD. MR: SÍ. REEV: EN 10 AÑOS. • SE SUGIERE RECHAZAR SOLICITUD DADO QUE LOS DIAGNÓSTICOS REPORTADOS NO GENERAN LIMITACIÓN EN LA FUNCIONALIDAD NI RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN. MR: NO. REEV: NO.
--	---

Notas:

Tanto en propuestas que consideren la reducción del % obtenido en IVADEC, o bien se propone Rechazo de la solicitud, se debe agregar la Glosa de Reducción de % o Rechazo según corresponda, utilizando como material de apoyo Anexo de Glosas.

Al finalizar la propuesta, a modo de firma, se debe agregar nombre de analista y profesión.

Como parte del Sistema de Gestión de Calidad institucional, como medio verificador de la revisión de los datos de usuario en esta etapa se debe agregar al final de la propuesta la nota: "DATOS DE USUARIO REVISADOS".